

## Fratura exposta · Gustilo e ATB precoce

Fratura exposta é emergência: ATB precoce, antitetânico, limpeza cirúrgica e estabilização. A classificação de Gustilo orienta cobertura e urgência.

### ATB de porta

#### Dica - ATB de porta

Inicie o mais cedo possível (ideal <3 h). Cefalosporina 1<sup>a</sup>/2<sup>a</sup> para I–II; acrescente Gram" (aminoglicosídeo ou equivalente) e, se contaminação rural/clostruídios, penicilina conforme protocolo.

*Quanto maior a energia e a lesão de partes moles, maior a chance de infecção e necessidade de cobertura.*



### Passos obrigatórios

- ABC do trauma, controle de hemorragia, alinhamento e imobilização
- Cobertura estéril úmida; não 'explorar' ferida na sala de emergência
- Profilaxia antitetânica conforme histórico vacinal
- Centro cirúrgico: irrigação abundante, desbridamento, fixação (externa se grave)

### III — subtipos

#### Subtipo | Característica

- IIIA | Cobertura óssea possível com partes moles
- IIIB | Precisa retalho / perda extensa
- IIIC | Lesão arterial que exige reparo

### Armadilha de prova

#### Atenção - Armadilha de prova

Atraso de antibiótico aumenta infecção — priorize ATB sobre 'espera do ortopedista'. Tipo IIIC: ameaça de membro; vascular + ortopedia juntos.

### Para a prova — escalas e macetes

#### Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Fratura exposta: ATLS primeiro, depois Gustilo-Anderson para ATB, lavagem e timing de cobertura/fixação.

Tipo III tem lesão de partes moles grave; IIIC = lesão arterial que requer reparo.

## Gustilo-Anderson

Fratura exposta - tipos

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| I - ferida limpa <1 cm                | Baixa energia   |
| II - >1 cm, contusão moderada         | Energia média   |
| IIIA - ampla, cobertura óssea ok      | Alta energia    |
| IIIB - precisa de retalho / cobertura | Periosteio ruim |
| IIIC - lesão arterial associada       | Reparo vascular |

I limpa <1cm | II >1cm moderada | IIIA cobertura | IIIB precisa retalho | IIIC arterial

## Sequência inicial

### Lembre - Sequência inicial

ABCDE, hemorragia, alinhar e imobilizar, cobrir com curativo úmido estéril, ATB precoce + tétano, foto se possível, irrigação/desbridamento em centro cirúrgico.

### ATB empírico (ideia clássica)

#### Tipo | Cobertura

I-II | Cefalosporina 1ª geração (Gram+)

III | Adicionar Gram<sup>-</sup> (aminoglicosídeo / equivalente)

Solo / fazenda | Considerar penicilina (Clostridium)

Água / especial | Cobertura conforme exposição

### Pontos de prova

- ATB o mais cedo possível reduz infecção
- Desbridamento cirúrgico; fixação provisória/definitiva conforme lesão
- IIIB/C: equipe plástica/vascular; cobertura precoce da exposição óssea
- Não 'enterrar' contaminação — lavagem abundante sob visão

## Síndrome compartimental

### Atenção - Síndrome compartimental

Dor desproporcional, dor à extensão passiva, tensão — fasciotomia. Pulso presente não exclui.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1